PROTOCOLLO 10

Classificazione clinica del quadro DC/TMD

Sintetizzare i dati per definire il quadro e il percorso

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Fine della prima valutazione	Tutti i quadri	10 minuti	Prima visita

Indicazioni

- ✓ Al termine della valutazione
- ✓ Prima di comunicare con il medico o l'odontoiatra
- ✓ Alla rivalutazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, per la restituzione.

Fisioterapista: con i dati raccolti e lo schema decisionale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Dolore

Mialgia, dolore miofasciale con riferito, artralgia, cefalea attribuita a DTM.

2



FASE 2

Disturbi articolari

Spostamento discale con o senza riduzione, malattia degenerativa, sublussazione.

3



FASE 3

Fattori associati

Cervicale, parafunzioni, Asse II.

4



FASE 4

Piano

Obiettivi, protocolli del kit e frequenza delle sedute.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Output	quadro principale e secondario
Obiettivi	SMART, condivisi
Rivalutazione	dopo 4 sedute

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Spesso coesistono quadri muscolari e articolari
- ✓ Spiega la diagnosi con parole semplici
- ✓ Collega ogni obiettivo a un protocollo

Errori da evitare

- ! Etichettare il paziente senza spiegazioni
- ! Pianificare senza obiettivi misurabili
- ! Ignorare il quadro secondario

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Obiettivo personale	Scegliere un'attività significativa da recuperare	da verificare a ogni rivalutazione

! **Nota clinica.** Una classificazione chiara facilita il dialogo con odontoiatri e gnatologi e la scelta dei protocolli.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.